ESTUDIO DE COHORTE · BEIJING · N = 487

Obesidad, lípidos y diabetes gestacional

Embarazadas con IMC ≥ 28 kg/m² seguidas desde el primer trimestre

1 · FRECUENCIA

41.5%

desarrolló DMG (202 de 487). En la población general de China: 14.8 %.

Según grado de obesidad



2 · FACTOR MÁS FUERTE

OR 5.2

Glucemia en ayunas del 1.er trimestre: único factor independiente de DMG. Punto clave: 5.1 mmol/L.

88% Glucemia ≥ 5.1 mmol/L y edad ≥ 35 años

15% TG < 1.5, glucemia < 4.9 y HDL-C ≥ 1.3 mmol/L

3 · TRIGLICÉRIDOS (1.ER TRIMESTRE)

En obesidad leve y moderada, el punto de corte es mucho menor que el de la guía general.

Obesidad leve	1.5 mmol/L
Obesidad moderada	1.4 mmol/L
Guía población general	2.8 mmol/L

Capacidad predictiva modesta (AUC ≈ 0.63). Obesidad grave: n = 24, sin diferencias.

CÓMO SE HIZO

575 reclutadas, **487** analizadas (oct 2021 – oct 2022)

Lípidos y glucosa en tres momentos: semanas 6-12, 24-28 y 34-37

Diagnóstico de DMG: prueba de tolerancia a 75 g en semanas 24-28 (ayunas ≥ 5.1; 1 h ≥ 10.0; 2 h ≥ 8.5 mmol/L)

Grados: leve 28-30, moderada 30-35, grave ≥ 35 kg/m²

CON DMG VS SIN DMG · 1.ER TRIM.

Indicador	DMG	Sin DMG
Glucemia	5.0	4.7
TG	1.5	1.2
LDL-C	2.7	2.5
Col. total	4.5	4.4
HDL-C	1.3	1.4

mmol/L, medianas. HDL-C sin diferencia significativa (P = 0.061).

PESO GESTACIONAL

3.5 kg

ganancia mediana a la semana 24, igual con y sin DMG (P = 0.246).

Obesidad grave ganó menos peso (0.0 kg) que la leve (4.0 kg), pero tuvo más DMG.

Controlar solo el peso no basta.

QUÉ HACER EN LA PRÁCTICA

1. Medir glucosa y lípidos en la primera consulta.

2. Educación y manejo del peso desde el primer trimestre.

3. Menos grasas saturadas y trans; más verduras, cereales integrales, fibra y pescado.

4. Idealmente, empezar antes del embarazo.

Vigilar glucosa y triglicéridos desde el primer trimestre.

Wei JX, Zhou L. Chin J Perinat Med. 2025;28(5):353-362